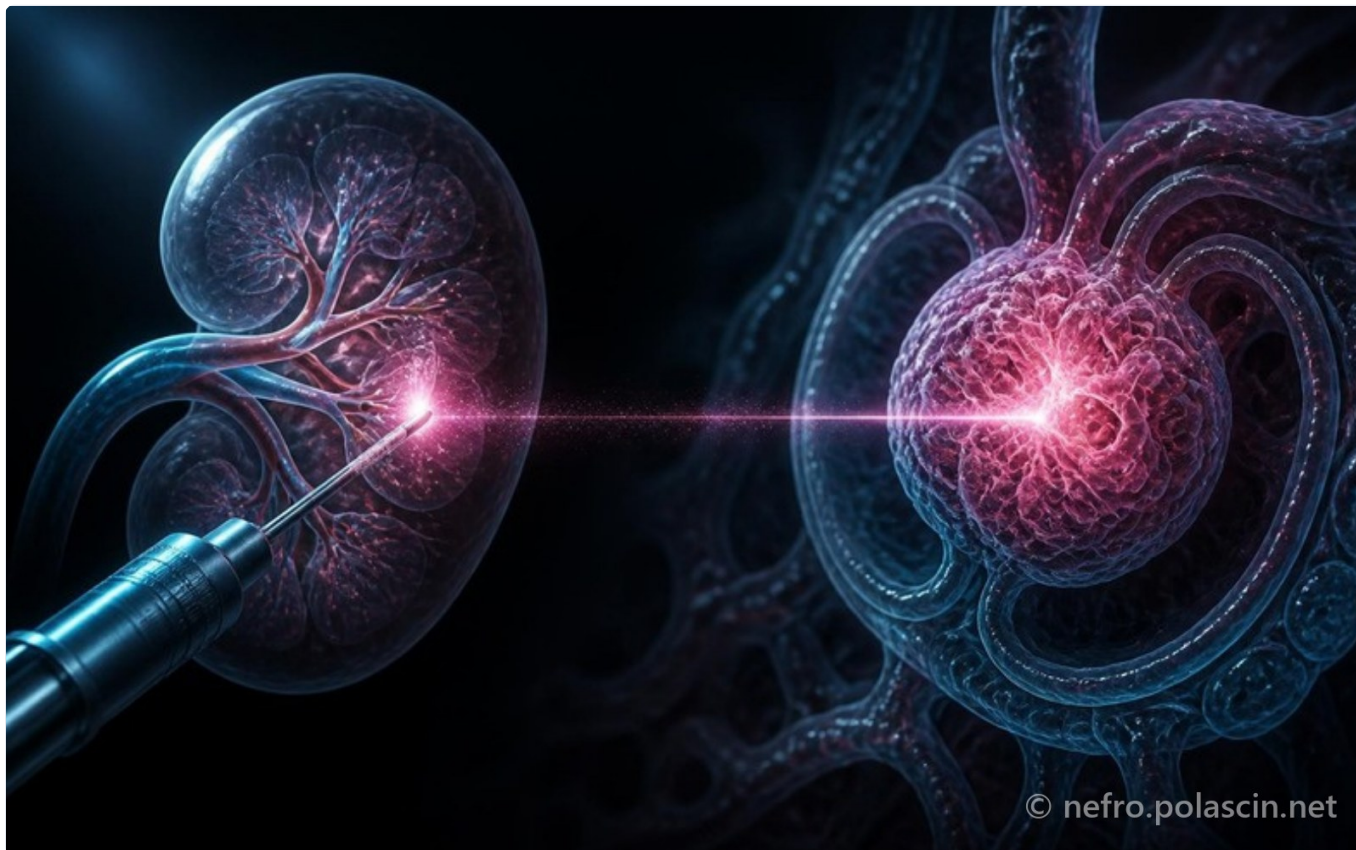


# IgA nefropatia podľa KDIGO 2025 a KDOQI US Commentary: od biopsie po cielenejšiu liečbu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.10.2026



Poloschematická vizualizácia. Biopsia nie je formalita — z nej sa odvíja, ktorá cieleňá liečba má pre pacienta zmysel.

IgA nefropatia (IgAN) je heterogénne imunitne podmienené ochorenie s variabilným klinickým priebehom. Praktický prínos KDIGO 2025 spočíva v tom, že posúva manažment smerom k včasnému rozpoznaní rizikových pacientov a k liečbe zameranej na hlavné mechanizmy ochorenia. KDOQI US Commentary zároveň spresňuje, ako tieto odporúčania implementovať v každodennej klinickej praxi.

## 1) Diagnóza IgAN: kľúčová je biopsia

KDOQI commentary súhlasí s tým, že **IgAN možno potvrdiť iba obličkovou biopsiou**. Neexistujú validované sérové ani močové biomarkery, ktoré by diagnózu spoľahlivo nahradili.

### Kedy uvažovať o biopsii

KDIGO odporúča biopsiu zvážiť u dospelých s **proteinúriou  $\geq 0,5$  g/deň** alebo ekvivalentom, ak IgAN prichádza do úvahy a biopsia nie je kontraindikovaná.

### Po potvrdení diagnózy

Po potvrdení IgAN sa má zhodnotiť aj možné **sekundárne pozadie** a pri primárnej IgAN sa má určiť **MEST-C skóre** podľa revidovanej Oxford klasifikácie.

## 2) Prognóza: riziko sa dá kvantifikovať, odpoveď na liečbu nie

KDIGO aj KDOQI zdôrazňujú, že pri IgAN nie sú validované prognostické biomarkery v krvi ani v moči. Prognóza sa preto opiera najmä o:

- **eGFR,**

- **proteinúriu.**

## **IgAN prediction tools**

Medzinárodné predikčné nástroje majú význam na **rizikovú stratifikáciu** a môžu podporiť zdieľané rozhodovanie s pacientom. KDOQI však upozorňuje, že tieto nástroje **nemajú slúžiť na výber konkrétneho lieku** ani na predikciu, kto na ktorú liečbu zareaguje. Neodporúčajú sa ani pre atypické fenotypy, ktoré neboli v pôvodných kohortách dostatočne zastúpené, napríklad pri akútnej nefritickej prezentácii, nefrotickom syndróme alebo rýchlo progredujúcej glomerulonefritide.

## **3) Cieľ liečby: spomaliť pokles eGFR a stlačiť proteinúriu dole**

KDIGO nastavuje cieľ liečby tak, aby sa rýchlosť poklesu eGFR približovala fyziologickému tempu pre väčšinu dospelých, teda približne **< 1 ml/min/rok**. Najpraktickejším skorým markerom odpovede zostáva proteinúria, ktorá má byť minimálne **< 0,5 g/deň** a ideálne **< 0,3 g/deň**.

KDOQI zároveň pripomína, že u pacientov s pokročilým jazvením nemusí byť tento cieľ realisticky dosiahnuteľný a bude treba kombinovať farmakologické aj nefarmakologické postupy.

## **4) Základ liečby rizikových pacientov: zásah do viacerých mechanizmov naraz**

KDOQI commentary podporuje mechanistický rámec KDIGO: u väčšiny rizikových pacientov má manažment súčasne:

1. obmedziť tvorbu IgA-obsahujúcich imunitných komplexov a glomerulárne poškodenie s nimi spojené,
2. manažovať dôsledky straty nefrónov, pravdepodobne celoživotne.

Praktický dôraz je na kombinácii liekov pôsobiacich na viacero článkov patofyziológie, nie iba na izolované znižovanie proteinúrie bez adresovania mechanizmov ochorenia.

## **5) Praktické nefarmakologické a podporné kroky**

KDIGO praxové body sú konkrétne a v komentári sa zdôrazňuje, že nejde o „doplňky“, ale o reálne terapeutické zásahy:

- **zníženie príjmu sodíka** pod 2 g/deň,
- **ukončenie fajčenia a vapingu,**
- **kontrola hmotnosti** a vhodná aeróbna aktivita,
- **cieľ tlaku krvi  $\leq 120/70$  mm Hg,**
- **blokáda RAS** (ACEi/ARB) a podľa situácie aj stratégia na zníženie hyperfiltrácie,
- zváženie **inhibítora SGLT2** ako súčasti nefroprotektívneho rámca,
- komplexná kardiovaskulárna prevencia podľa lokálnych odporúčaní,
- v ideálnom prípade zváženie **klinickej skúšky**, ak je dostupná.

## **6) IgAN špecifická terapia: Nefecon ako preferovaná možnosť, ak je dostupný**

KDIGO odporúča **9-mesačnú kúru Nefeconu** u pacientov v riziku progresie, typicky v skupine 2B.

### **Čo treba vedieť pred začiatkom Nefeconu**

KDOQI commentary podporuje princíp odporúčania, ale pripomína praktické limity:

- odpoveď nemusí byť dlhodobá po ukončení liečby,
- údaje o opakovaných cykloch sú stále obmedzené,
- dostupnosť a schválenie sa medzi krajinami líšia.

### **Bezpečnosť a systémový tieň lokálneho steroidu**

Aj keď je Nefecon koncipovaný ako lokálny kortikosteroid s menšou systémovou expozíciou, KDOQI upozorňuje, že treba počítať s limitovanou absorpciou a klinicky významnými nežiaducimi účinkami. V štúdií boli závažné nežiaduce udalosti počas 9-mesačnej liečby častejšie v aktívnej skupine a častejšie bolo aj ukončenie liečby pre

nežiaduce udalosti. V úvode liečby sa môže objaviť aj fenomén **reverse dip** na eGFR.

V praxi je preto dôležité pacientovi vysvetliť, že krátkodobé zmeny proteinúrie alebo eGFR ešte neznamenajú neúspech či úspech liečby.

## 7) Ak Nefecon nie je dostupný: znížená dávka systémových kortikoidov s profylaxiou

V prostredí bez Nefeconu KDOQI podporuje KDIGO odporúčanie použiť **6 až 9 mesiacov zníženej dávky systémového glukokortikoidu** s vhodnou profylaxiou.

### Odporúčaný režim methylprednizolónu

- **0,4 mg/kg/deň**, maximálne **32 mg/deň**, počas **2 mesiacov**,
- potom tapering o **4 mg/deň každý mesiac**,
- celková dĺžka liečby **6 až 9 mesiacov**.

### Povinná bezpečnostná vrstva

Liečba má byť sprevádzaná:

- **antimykotickou profylaxiou** proti *Pneumocystis jirovecii*,
- **antivírusovou profylaxiou** u nosičov HBsAg,
- **gastroprotekciou** a **ochranou kostí** podľa lokálnych odporúčaní.

### Pacienti s vyšším rizikom toxicity kortikoidov

KDOQI upozorňuje na zvýšenú obozretnosť najmä pri týchto faktoroch:

- eGFR < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>,
- diabetes alebo prediabetes,
- obezita,
- latentné infekcie, napríklad vírusové hepatitídy alebo tuberkulóza,
- aktívna peptická ulcerácia,
- nekontrolované psychiatrické ochorenie,
- osteoporóza,
- katarakta.

## Záver pre prax

V manažmente IgAN sa ťažisko presúva na tri body: správnu diagnostiku, včasné rizikové zhodnotenie a liečbu zameranú na mechanizmy ochorenia. Bez biopsie sa diagnóza potvrdiť nedá, proteinúria  $\geq 0,5$  g/deň nie je banálna a cieľom je spomaliť pokles eGFR. Nefecon je preferovaným 9-mesačným zásahom, ak je dostupný; pri nedostupnosti sa zvažujú znížené dávky systémových kortikoidov s profylaxiou.

---

**Zdroj:** KDOQI US Commentary on the KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for IgA Nephropathy and IgA Vasculitis (AJKD, full text). [Link na zdroj](#).

---

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-kdigo-2025-kdoqi> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.